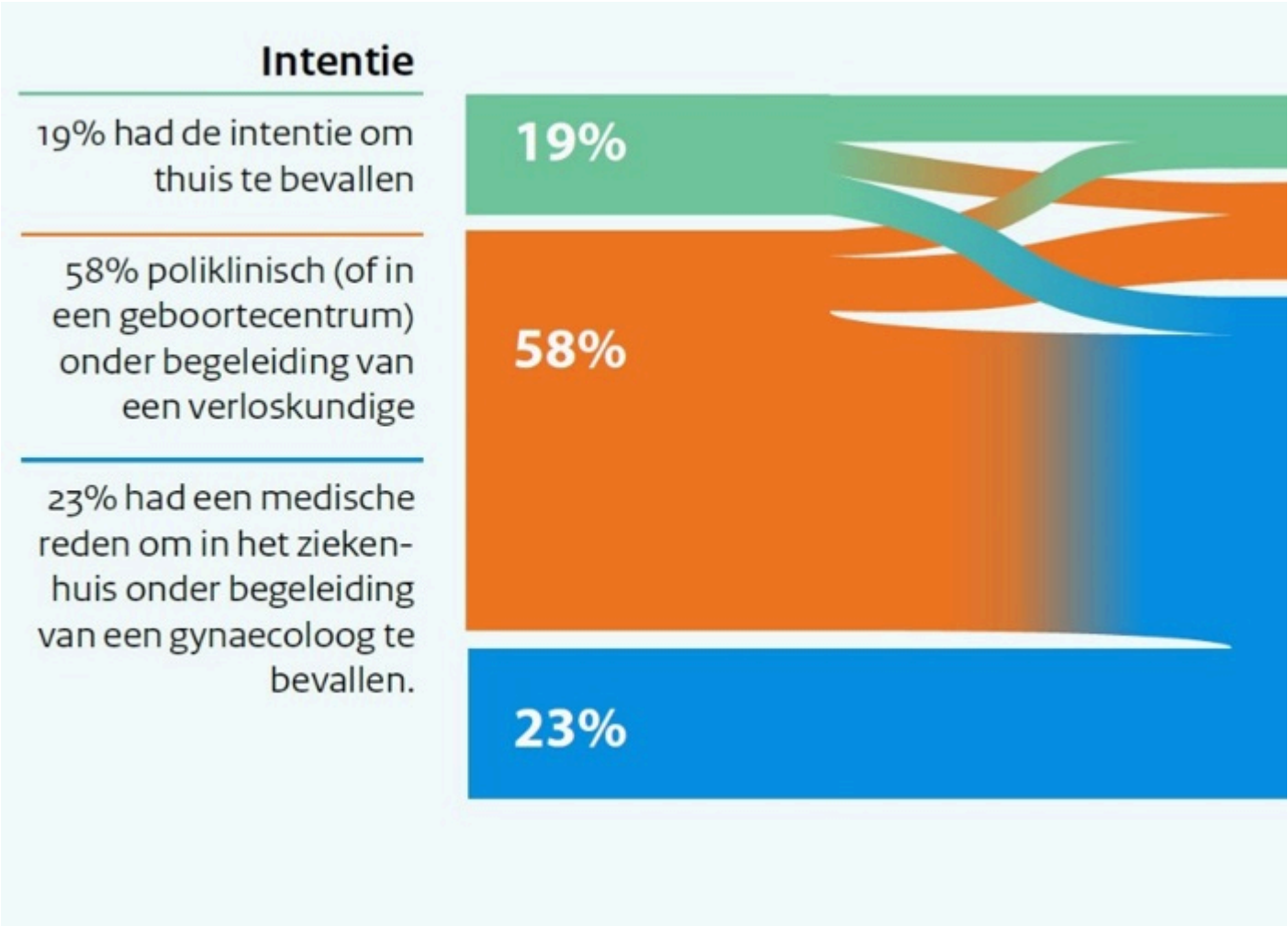
Voorbereiden op de bevalling

De geboorte van je kind is een unieke ervaring voor jou en je partner. Tijdens de zwangerschap bereidt jouw lichaam zich voor op de bevalling. Jij kunt dit zelf ook doen. Lees over zwangerschap of volg een voorbereidende cursus. Bespreek met de mensen die bij je bevalling zullen zijn, dus ook met je verloskundige of gynaecoloog, wat jouw ideeën en verwachtingen zijn over de bevalling. Elke bevalling is anders. Niemand kan van tevoren precies voorspellen hoe je bevalling zal verlopen. Een bevalling kan anders verlopen dan je van tevoren had verwacht.

Een paar feiten over bevallen in Nederland

Verloskundige of gynaecoloog?

Als alles in de zwangerschap en tijdens de bevalling zonder risicofactoren verloopt, mag je in Nederland bevallen met een zelfstandig verloskundige. Wanneer er risicofactoren ontstaan tijdens de zwangerschap of tijdens de bevalling verwijst de verloskundige je door naar de gynaecoloog. Voorbereiden op de bevalling
In Nederland begint de begeleiding van de zwangerschap bij 9 van de 10 zwangere vrouwen bij de verloskundige. Aan het begin van de bevalling worden 5 op de 10 zwangere vrouwen begeleid door de verloskundige en 5 op de 10 door de gynaecoloog. Als je tijdens je bevalling wordt overgedragen aan de gynaecoloog, gaat je eigen verloskundige naar huis en wordt je bevalling verder begeleid door het medisch team van het ziekenhuis.



In de helft van de gevallen draagt de verloskundige tijdens de bevalling de zorg over aan de gynaecoloog. De meest voorkomende redenen om tijdens een bevalling overgedragen te worden aan de gynaecoloog zijn:

- meconiumhoudend vruchtwater (de baby heeft in het vruchtwater gepoept)
- niet vorderen van de ontsluiting of van de baring
- behoefte aan pijnstilling (in Nederland krijgen 3 op de 10 vrouwen pijnstilling tijdens de bevalling)
- de vliezen zij n langer dan 24 uur gebroken zonder weeën.

Wanneer bevalling inleiden?

Bij 2 op de 10 vrouwen in Nederland wordt de bevalling ingeleid. Een paar voorbeelden van oorzaken waarom een bevalling wordt ingeleid zijn:

- een zwangerschapsduur langer dan 41-42 weken
- hoge bloeddruk
- zwangerschapsvergiftiging
- een baby die te weinig of te snel groeit.

Er bestaat een aparte folder over het inleiden van de bevalling

Vaginaal bevallen of via keizersnede?

8-9 op de 10 vrouwen bevallen vaginaal.
1 op de 10 vrouwen krijgt tijdens de bevalling hulp met een vacuumpomp of tang.
1-2 op de 10 vrouwen bevalt met een keizersnede.

In de helft van de keizersnedes is het een geplande keizersnede en in de andere helft is het een niet geplande keizersnede. Er is sprake van een niet geplande keizersnede wanneer een bevalling al gestart is en er tijdens de bevalling besloten wordt tot een keizersnede. Dit gebeurt als:

- de baarmoedermond (de ontsluiting) niet volledig open wil gaan bij goede weeën
- tijdens de bevalling blijkt dat de baby uitgeput raakt door de weeën
- er onvoldoende zuurstoftoevoer via de placenta en navelstreng is.

Ook ná de bevalling wordt minder dan 1 op de 10 vrouwen overgedragen aan de gynaecoloog, bijvoorbeeld vanwege teveel bloedverlies of een placenta die vast blijft zitten

Bij een bevalling onder leiding van de verloskundige wordt uitgegaan van een gezonde moeder en een gezonde baby. Daarom wordt de hartslag van de baby op gezette tijden gecontroleerd en niet continu.

Bij een bevalling onder leiding van de gynaecoloog wordt de conditie van de baby continu in de gaten gehouden. Dit gebeurt met twee banden om jouw buik om het hartritme van de baby en de weeën te registreren. Vaak krijg je een infuus. Als dat mogelijk is en veilig voor moeder en kind proberen de zorgverleners ook in deze situatie rekening te houden met jouw wensen. Bespreek je wensen.

Samenwerking

De verloskundigen in de regio Den Haag/Westland werken samen met de afdeling Gynaecologie in het HagaZiekenhuis en het Haga Juliana Geboortecentrum. Wanneer je al in het ziekenhuis bent om te bevallen en de zorg moet worden overgedragen van de verloskundige naar de gynaecoloog, dan blijf je op dezelfde kamer en verandert alleen het team.

Geboorteplan

Maak je wensen kenbaar door middel van een geboorteplan. Bespreek van tevoren met je partner en je verloskundige of gynaecoloog hoe jij je comfortabel kunt voelen in overwachte situaties. Het gaat om jouw bevalling; de zorgverleners zijn er voor jou en je kind! Niet alle wensen zijn mogelijk, maar alle wensen zijn bespreekbaar.

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

215406052025